

GRILE VARIANTA D

1.* Miopia:

- A. Reprezintă o tulburare de refracție în care razele paralele, venite de la infinit, se focalizează în fața retinei.
- B. Majoritatea miopiilor sunt datorită axului prea mic al globului ocular.
- C. Majoritatea miopiilor sunt datorită axului prea mare al globului ocular.
- D. Reprezintă o tulburare de refracție determinată de existența mai multor axe cu puteri diferite la nivelul corneei.
- E. Se corectează cu lentile cilindrice.

2*.Leziuni pigmentare ale conjunctivei sunt urmatoarele cu exceptia:

- A. Melanoza conjunctivala epiteliala
- B. Nev conjunctival
- C. Melanocitozele oculare congenitale
- D.Nev Ota
- E.Trahomul

3*etiologia hemoragiilor vitreene poate fi:

- A. Astigmatismul
- B. Keratita
- C. Rupturi retiniene
- D. Dacriocistita
- E. Trichiazisul

4* Hialitele:

- A. Sunt afectiuni degenreative ale corneei
- B. Sunt afectiuni maligne ale coroidei
- C. Sunt afectiuni inflamatorii ale vitrosului
- D. Sunt afectiuni inflamatorii retiniene
- E. Sunt afectiuni congenitale ale cristalinului

5*biometria preoperatorie se realizeaza pentru:

- A. A determina valoarea dioptrica a cristalinului artificial ce urmeaza a fi implantat in cadrul operatiei de cataracta
- B. A stabili tensiunea intraoculara
- C. A evalua tesutul corneean
- D. A examina functia nervului optic
- E. A determina campul vizual

6* . 1.Urmatoare afirmatie referitoare la orbita este corecta:

- A. Orbita I se descrie o baza situata superior,varf situat posterior si 4 pereti
- B. Orbita I se descrie o baza situata anterior,varf situat posterior si 4 pereti
- C. Orbita I se descrie o baza situata anterior ,varf situat medio-lateral si 4 pereti
- D. Orbita I se descrie o baza situata superior,varf situat posterior si 3 pereti
- E. Orbita I se descrie o baza situata posterior,varf situat anterior si 4 pereti

- 7 ABC 7*. Tunicile globului ocular sunt:
- A. Tunica externa: corneea, sclera
 - B. Tunica medie: coroida, corp ciliar, iris
 - C. Tunica interna: retina
 - D. Tunica medie: corneea, iris
 - E. Tunica interna: corpul vitros
- 8 B 8* Histologic, retina este formată din:
- A. 8 straturi
 - B. 10 straturi
 - C. 9 straturi
 - D. 11 straturi
 - E. Nici una din variantele de mai sus
- 9 D 9* Urmatoarele afirmatii referitoare la exofalmia din boala Basedow sunt adevarate:
- A. este cea mai rara forma de exoftalmie
 - B. muschii orbitari sunt atrofiati
 - C. in forma benigna acuitatea vizuala este afectata
 - D. in forma maligna exoftalmia este marcata
 - E. atat in forma maligna cat si in forma benigna nervul optic este afectat
- 10 E 10* Actiunea izolata a muschiului drept intern este:
- A. abductie
 - B. coborator
 - C. ridicator
 - D. rotator
 - E. adductie
- 11 AD 11. Conjunctiva:
- A. Este o mucoasă subțire ce unește pleoapele cu globul ocular.
 - B. I se descriu 3 porțiuni: marginală, tarsală, orbitală.
 - C. Structură: piele, țesut celular subcutanat, strat muscular.
 - D. Prezintă glande inervate parasimpatic din nervul facial (Krause și Wolfring)
 - E. Vascularizația este asigurată de artera centrală a retinei.
- 12 ABCE 12. Următoarele afirmații sunt false:
- A. Procesul de acomodatie este procesul prin care corneea se bombează și își crește puterea de refracție.
 - B. În hipermetropie, axul ocular este prea lung.
 - C. Puterea refractivă totală a sistemului ocular este de 99,56 D.
 - D. Testul Snellen este folosit pentru măsurarea acuității vizuale.
 - E. Puterea refractiva totala a sistemului ocular este de 60 D

13 CE

13. Următoarele afirmații sunt false:

- A. Chiasma optică este o structură nervoasă în forma literei X
- B. Aria Brodmann 17 (V1) reprezintă cortexul vizual primar.
- C. Umoarea apoasă este un lichid cu compoziție asemănătoare vitrosului.
- D. Umoarea apoasă este produsă la nivelul pars plicata a corpului ciliar.
- E. Cristalinul este o structură avasculară situată la nivelul polului posterior al globului ocular.

14 ABE

14. Următoarele afirmații sunt adevărate:

- A. Entropionul reprezintă o inversare a marginii libere palpebrale.
- B. Simblefaronul reduce mobilitatea pleoapei.
- C. Sindromul de pleoape floppy se manifestă prin pleoape inferioare cu tonus crescut.
- D. Dermatita atopică palpebrală se asociază des cu cataracta.
- E. Orjeletul se datorează infecției acute a unei glande Zeiss sau a unei glande Moll cu stafilococul auriu.

15 CD

15. Afecțiuni inflamatorii ale glandei lacrimale sunt :

- A. Dacriocistita acută
- B. Dacriocistita cronică
- C. Dacrioadenita acută
- D. Dacrioadenita cronică
- E. Epifora

16 BCE

16. Pterigionul

- A. nu recidivează după ce este înlăturat chirurgical
- B. apare mai frecvent la oamenii pigmentați, mai des expuși radiației solare și pulberilor în suspensie
- C. în general, leziunea este unilaterală (75% din cazuri), dar poate fi și bilaterală
- D. în general, leziunea este bilaterală (75% din cazuri), dar poate fi și unilaterală
- E. din punct de vedere evolutiv, există o fază activă, de creștere a leziunii, și o fază de staționare

17 ABCD

17. Traumatismele sclerale:

- A. cuprind: plăgi, rupturi și arsuri.
- B. plăgile sclerale pot fi superficiale sau perforante. Cele superficiale interesează episclera și se vindecă ușor cu un tratament local antiinfecțios
- C. arsurile sclerei însoțesc arsurile grave ale conjunctivei, ele sunt de grade diferite
- D. rupturile sclerale cel mai frecvent se localizează în apropierea limbului sclero-cornean, regiune cu rezistență redusă
- E. rupturile sclerale cel mai frecvent se localizează în apropierea limbului sclero-cornean, regiune cu rezistență maximă

18 ABCD

18. Episclerita:

- A. semne și simptome: dureri, hiperlacrimare, fotofobie, roșeață, edem și o ușoară proeminență circumscrisă
- B. o picătură de adrenalină va face să dispară congestia conjunctivală ce însoțește flictena, pe când congestia sclerală persistă sau se reduce parțial.
- C. Diagnosticul diferențial se face cu conjunctivita flictenulară

- D. printre primele semne poate sa fie un nodul dureros inconjurat de o zona hiperemica
- E. boala evoluează în general cu complicații majore

19 Aprecierea secreției lacrimale se face prin intermediul unor teste:

- A. Testul Schirmer: utilizat pentru secreția bazală și reflexă; un test din hartie de filtru este poziționat în fundul de sac conjunctival inferior al ambilor ochi.
- B. Timpul de rupere a filmului lacrimal
- C. Evaluarea epitelului cornean și conjunctival: se colorează cu fluoresceină și se evaluează modificările corneene.
- D. Testul Seidel
- E. Testul Ishihara

20 Conjunctivitele bacteriene:

- A. sunt inflamatii septice ale conjunctivei
- B. la debut secretia conjunctivala abundenta este seroasa, transformandu-se în cateva zile în mucopurulenta
- C. este necesara administrarea sistemica de antibiotic
- D. pacientul se plange de senzatie de arsura a suprafetei oculare, asociata cu prurit
- E. toata simptomatologia amintita debuteaza brusc

21. Keratoconjunctivitele sicca:

- A. reunesc un grup de afectiuni în care elementul central îl reprezinta hiposecretia lacrimală
- B. semne clinice: corneea prezinta dezepitelizari punctiforme în treimea inferioara, cu microfilamente aderente de marginea leziunii epiteliale
- C. se administreaza lubrifianti oculari în coliruri, geluri sau suspensii pulverizate, cu rol în substitutia cantitativa lacrimală
- D. se administreaza antibioterapie sistemica
- E. se poate interveni chirurgical

22. Următoarele afirmații sunt adevărate:

- A. Trichiazisul reprezintă o maldirecționare a cililor palpebrali, astfel încât aceștia privesc cu vârful lor spre globul ocular.
- B. Madaroza= scăderea numărului de cili palpebrali sau chiar pierderea totală a acestora.
- C. Tratamentul madarozei: nu exista un tratament eficient, în afara unor geluri/pomezi aplicabile palpebral.
- D. Polioza reprezintă creșterea numărului de cili palpebrali.
- E. Tratamentul poliozei este strict chirurgical.

23 Modificările papilei nervului optic din boala glaucomatoasă constau în:

- A. lărgirea în volum a excavației optice în raport cu dimensiunea totală a corpului nervului optic respectiv inversarea raportului C/D peste 0,1
- B. iluzia optică ce dă un aspect de deplasare temporală a vaselor de la nivelul PNO
- C. hemoragii la nivelul discului optic
- D. focare de atrofie a țesutului peripapilar
- E. apariția orificiilor „laminei criblate”

24 CDE

24. Substanțele active ce compun colirele antiglaucomatoase sunt:

- A. analogii de prostaglandină: brimonidina
- B. alfaagoniști adrenergici: latanoprost
- C. betablocanți neselectivi sau selectivi: carteololul, betaxololul, maleatul de timolol, levobunololul
- D. inhibitorii topici de anhidrază carbonică: dorzolamida
- E. agenții parasimpatomimetici (mioticele): pilocarpina clorhidrică

25 BDE

25. Simptomatologia obiectivă a GPUI e caracterizată prin:

- A. presiune intraoculară PIO foarte scăzută (3-7mmHg)
- B. edem corneean predominant epitelial asociat cu rupturi endotelio-descemetice
- C. pupilă miotică, neregulată, areflexică
- D. camera anterioară de profunzime redusă
- E. congestie perikeratică mixtă

26 AB

26. Cauze de glaucom neovascular:

- A. retinopatia diabetică
- B. obliterarea de venă centrală a retinei sau de ram venos
- C. retinopatia hipertensivă
- D. degenerescența maculară legată de vârstă
- E. nevrita optică

27 BCE

27. OVCR ischemică (neperfuzată) caracteristici:

- A. acuitatea vizuală este relativ conservată sau moderat afectată
- B. defectul pupilar aferent relativ (DPA) este prezent
- C. vene dilatate și tortuoase, hemoragii în forma de flacără, noduli cotoñoși; edem papilar sever și hiperemie
- D. . Angiofluorografia (AFG): se observă o întârziere a timpului de tranzit arterio-venos, perfuzie capilară păstrată
- E. prognosticul este rezervat datorită ischemiei

28 BCE

28. Care dintre următoarele afirmații despre Neuropatia optică ereditară Leber sunt adevărate?

- A. apare datorită transmiterii unei mutații punctiforme în ARN-ul mitocondrial
- B. transmiterea se face pe cale paternă
- C. pierderea vederii bilaterală, secvențială, în principal la bărbații tineri
- D. produce discromatopsie cu debut subacut
- E. pacienții prezintă o recuperare minimă

29 AB

29. următoarele afirmatii referitoare la Keratoconus sunt false:

- A. Este o ectazie conică bilaterală , inflamatorie
- B. Corneea este mai groasă în zona central
- C. Corneea este mai subțire în zona central
- D. În vederea stopării evoluției se poate efectua cross-linking cu riboflavină
- E. Pentru stadiile mai avansate, singura opțiune terapeutică este transplantul de corneea

30. Urmatoarele afirmatii referitoare la keratita herpetica sunt false:

30 CD

- A. Aspectul patognomonic dendritiform se pune în evidență la biomicroscopie cu ajutorul fluoresceinei
- B. Recidivele sunt foarte frecvente
- C. Se indica corticosteroizii topic inaintea reepitelizarii complete a corneei
- D. Afectiunea apare de regula insidios si bilateral
- E. Simptomele subiective sunt: lacrimarea, fotofobia, durerea oculara, anestezia sau hipoestezia corneeană

31. tratamentul postoperator al cataractei consta in:

31 BD

- A. Administrarea de coliruri anestezice
- B. Administrarea de colirului cu corticosteroizi,
- C. Administrarea de coliruri miotice
- D. Administrarea de coliruri antibiotice
- E. Administrarea de coliruri antivirale

32. Chalazionul:

32 ADE

- A. Este o afecțiune inflamatorie chistică a pleoapei
- B. Este o afecțiune foarte rar întâlnită
- C. Este asimptomatic dacă chistul lipogranulomatos este de dimensiuni mari
- D. Apare datorită obstrucției orificiului de evacuare a secreției meibomiene
- E. Tratamentul de elecție al chalasioanelor de dimensiuni mari este chirurgical

33. Ectropionul:

33 AD

- A. Reprezintă o eversare a marginii libere palpebrale, afectând mai des pleoapa inferioară
- B. Reprezintă o inversare a marginii libere palpebrale, afectând mai des pleoapa inferioară
- C. Reprezintă o eversare a marginii libere palpebrale, afectând mai des pleoapa superioară
- D. Indiferent de forma ectropionului, tratamentul este întotdeauna chirurgical
- E. Se poate trata prin injectare cu toxina botulinică

34. Carcinomul cutanat bazocelular al pleoapei:

34 BCDE

- A. Este tumora benignă cel mai des întâlnită de la acest nivel
- B. Apare în special la persoanele în vârstă
- C. Poate afecta orice regiune topografică a pleoapei
- D. Tratamentul de bază îl reprezintă excizia chirurgicală
- E. Examenul histopatologic al piesei excizate este obligatoriu

35. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

35 ACD

- A. Miopia este un viciu de refracție în care razele paralele, venite de la infinit, se focalizează înaintea retinei
- B. Hipermetropia este un viciu de refracție în care razele paralele, venite de la infinit, se focalizează înaintea retinei
- C. Hipermetropia este un viciu de refracție în care razele paralele, venite de la infinit, se focalizează înăpoia retinei
- D. Astigmatismul este un viciu de refracție determinat de existența mai multor axe cu puteri diferite la nivelul corneei.

- E. Astigmatismul este un viciu de refractie determinat de existenta mai multor axe cu puteri diferite la nivelul cristalinului.

36. Mediile transparente ale globului ocular sunt reprezentate de:

- A. Corneea
B. Corp ciliar
C. Corp vitros
D. Cristalin
E. Umoarea apoasa

37. Urmatoarele afirmatii referitoare la miopie sunt adevarate

- A. Este o tulburare de refractie in care razele paralele, venite de la infinit, se focalizeaza in spatele retinei
B. Este o tulburare de refractie in care razele paralele, venite de la infinit, se focalizeaza in fata retinei
C. Unul dintre factorii majori ce determina cresterea axului ocular este activitatea indelungata la aproape
D. Se corecteaza cu lentile cilindrice notate cu plus
E. La majoritatea pacientilor, procesul de crestere al dimensiunilor globului ocular se opreste inaintea varstei de 30 de ani

38. Urmatoarele afirmatii sunt false:

- A. Dacriocistita reprezinta procesul inflamator al sacului lacrimal
B. Hiperlacrimarea primara apare datorita iritatiei corneene
C. Hiperlacrimarea reflexa apare datorita afectarii directe a glandei lacrimale
D. Epifora este forma de lacrimare excesiva care apare datorita imposibilitatii drenarii lacrimilor
E. Dacriocistita reprezinta procesul inflamator al glandei lacrimale

39. Herpesul zoster oftalmic:

- A. Reprezinta manifestarea clinica cutanata a infectiei cu virusul varicelo-zosterian la nivelul pleoapei superioare
B. De regula, afectiunea se localizeaza la ambele pleoape superioare
C. De regula, afectiunea se localizeaza la una din pleoapele superioare
D. Afectiunea se intaleste de regula la tineri
E. Afectiunea se intaleste de regula la varstnici

40. Conjunctivitele:

- A. În conjunctivita bacteriana, conjunctiva este hiperemică, congestionată
B. Conjunctivitele cu adenovirusuri nu sunt contagioase
C. Tratamentul conjunctivitelor virale: coliruri miotice
D. Conjunctivita vernală(primăvărată) are la bază o reacție de hipersensibilitate de tip I și IV
E. În keratoconjunctivita Sicca elemental central îl reprezintă hiposecreția lacrimală sau evaporarea în exces a apei din filmul lacrimal

- 41 BCD** 41. Urmatoarele afirmatii referitoare la episclerita sunt false:
- A. O picatura de Adrenalina va face sa dispara congestia conjunctivala
 - B. Reprezinta un proces inflamator profund sever
 - C. Se asociaza frecvent cu o boala cum ar fi poliartrita reumatoida, etc
 - D. Boala evolueaza cu multe complicatii ale organelor invecinate
 - E. Boala are caracter recidivant
- 42 CDE** 42. Urmatoarele afirmatii despre hemangioamele orbitare cavernoase sunt adevarate:
- A. sunt cele mai rare dintre angioamele orbitare
 - B. apar mai frecvent la copil
 - C. apar mai frecvent la adult
 - D. sunt bine delimitate, incapsulate
 - E. se indeparteaza cu usurinta
- 43 ACE** 43. Semnele obiective la pacientul cu flegmon orbitare sunt:
- A. exoftalmie accentuata
 - B. enoftalmie
 - C. pupila in midriaza
 - D. pupila miotica
 - E. chemozis accentuat
- 44 ACDE** 44. Care sunt modificarile clinice in paralizia de nerv VI – abducens ?
- A. prezenta esotropiei
 - B. prezenta exotropiei
 - C. falsa proiectie in directia muschiului paralizat
 - D. pozitia vicioasa a capului
 - E. diplopia homonima
- 45 ADE** 45. Care sunt cauze care pot determina enoftalmie :
- A. traumatisme obstetricale
 - B. hidrocefalia
 - C. boala Basedow
 - D. sindromul Horner
 - E. malformații orbitare
- 46 CDE** 46. Rupturile sclerale
- A. Se produc in zone de rezistenta crescuta
 - B. Sunt extrem de rare
 - C. Se produc in zone de minima rezistenta
 - D. Se produc la nivelul ecuatorului globului ocular zona unde sclera este mai subtire
 - E. Se produc in apropierea limbului sclero-cornean
- 47 CDE** 47. Indicația absolută pentru enuclearea globului ocular este reprezentata de
- A. Plagi de mici dimensiuni
 - B. Plagi intepate
 - C. Plăgile mari zdrobite

- D. Plagile a căror coaptare este imposibilă
- E. Plagile însoțite de distrugerii intraoculare grave

48. Urmatoarele afirmatii legate de prezenta corpiilor straini intraoculari sunt adevarate

- A. Examenul radiologic nu reprezinta o optiune valida in aceste conditii
- B. O metodă foarte importantă pentru descoperirea și localizarea corpiilor străini intraoculari o constituie examenul radiologic
- C. Când este localizat la nivelul polului posterior (retina, coroida) iar mediile oculare sunt transparente, el poate fi descoperit la examenul oftalmoscopic
- D. Una dintre tehnicile radiologice utilizate este metoda Comberg
- E. Când este localizat la nivelul polului posterior (retina, coroida) iar mediile oculare sunt opace, pot fi descoperiti la examenul oftalmoscopic

48 BCD

49. Urmatoarele afirmatii sunt false

- A. Corpii straini intraorbitari tolerati sunt lasati pe loc
- B. Corpii straini intraorbitari tolerati necesita extractie imediata
- C. In cazul corpiilor straini netolerati nu se initiaza tratament antibiotic și antiinflamator pentru prevenirea apariției abcesului orbital
- D. Corpii straini intraorbitari din material vegetal trebuie extrasi
- E. In cazul corpiilor straini netolerati se initiaza tratament antibiotic și antiinflamator pentru prevenirea apariției abcesului orbital

BC

50. Care sunt semnele obiective in tromboflebita de sinus cavernos ?

- A. edem palpebral
- B. enoftalmie
- C. exoftalmie axiale
- D. glob imobil
- E. palparea este nedureroasa

50 ACD

